Chirurgická ambulance - koloproktologická poradna

Ambulantní vyšetření kontrolní

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111
Datum vyšetření: 8.10.2026

Diagnózy: C20 Zhoubný novotvar konečníku
Z93.2 Ileostomie

Závěr:
Adenokarcinom rekta (horní okraj 11 cm, dolní okraj 6 cm od anu), G2, pMMR, diag. 3/2026

- 2/2026 enteroragie a změna defekačního stereotypu, anémie (Hb 108 g/l dne 10.3.2026)
- 9.3.2026 koloskopie (popis z NIS): exofytický tumor rekta 6-11 cm od anu, semicirkulární, odebrána biopsie, zbytek tračníku bez patologie
- Histol. biopsie 12.3.2026: adenokarcinom, G2, MMR proteiny zachovány (pMMR) - viz bioptický nález
- MR pánve 16.3.2026 (popis z NIS): tumor rekta s šířením do mezorekta 7 mm za muscularis propria, 2 suspektní mezorektální uzliny, MRF negativní, EMVI negativní, závěr cT3b cN1
- CT hrudníku a břicha 17.3.2026 (popis z NIS): bez známek vzdálených metastáz
- Stadium před léčbou: cT3b cN1 cM0 (MR pánve 16.3.2026, CT 17.3.2026)
- 20.3.2026 MDT: indikována neoadjuvantní chemoradioterapie
- 7.4.2026 - 18.5.2026 neoadjuvantní CHRT: RT 50,4 Gy/28 fr. na oblast pánve + kapecitabin 825 mg/m2 2x denně ve dnech RT, bez přerušení
- MR pánve 20.7.2026 (popis z NIS): regrese tumoru, reziduální ztluštění stěny rekta, bez suspektních uzlin, MRF negativní
- 11.8.2026 nízká přední resekce rekta s TME, staplerová anastomóza, protektivní ileostomie (operační protokol v NIS)
- Histol. resekátu 21.8.2026: ypT2 ypN0 (0/14), R0, CRM 9 mm, TRG 2 - viz bioptický nález
- Stadium po neoadjuvanci: ypT2 ypN0 cM0 (histologie resekátu 21.8.2026)
- 9/2026 vyšší odvod z ileostomie (do 1500 ml/den), dehydratace s prerenálním vzestupem kreatininu (104 µmol/l dne 15.9.2026), upraveno p.o. rehydratací a loperamidem
- CEA: 14,8 µg/l (10.3.2026), 5,8 µg/l (2.6.2026), 2,9 µg/l (15.9.2026), 9,6 µg/l (6.10.2026)
- 7.10.2026 odeslána žádanka na CT hrudníku, břicha a pánve pro vzestup CEA, t.č. výsledek nemáme

Subjektivně:
Cítí se dobře, chuť k jídlu dobrá, hmotnost stabilní. Odvod z ileostomie nyní 600-800 ml/den, kašovitý. Bolesti břicha neguje. Kašel neguje.

Objektivně:
ECOG 1. Hmotnost 64 kg, výška 165 cm. Břicho měkké, nebolestivé, jizvy klidné. Ileostomie vpravo vitální, okolí bez macerace. Per rectum: anastomóza hmatná cca 5 cm od anu, hladká, bez rezistence.

Lipenská Věra, nar. 14.6.1958, r.č. 585614/4019, poj. 111 - Ambulantní vyšetření kontrolní 8.10.2026, pokračování

Anamnéza:
OA: arteriální hypertenze, hypotyreóza na substituci. DM neguje.
FA: Perindopril 4 mg 1-0-0, Levothyroxin 75 µg 1-0-0, Loperamid 2 mg dle odvodu ze stomie, Pantoprazol 20 mg 1-0-0
AA: neguje
Abusus: nekuřačka, alkohol neguje
SA: vdaná, účetní, t.č. ve starobním důchodu

Laboratoř (odběr 6.10.2026 07:20):
CEA 9,6 µg/l, CA 19-9 27,8 kU/l, Hb 124 g/l, kreatinin 78 µmol/l, jaterní testy v normě - viz výsledkový list.

Zhodnocení:
Stav po neoadjuvantní CHRT a nízké přední resekci rekta s TME pro adenokarcinom rekta cT3b cN1 cM0, po léčbě ypT2 ypN0 (0/14), R0. Po pooperačním poklesu CEA do normy (2,9 µg/l dne 15.9.2026) nyní opětovný vzestup na 9,6 µg/l (6.10.2026). Klinicky bez známek recidivy, restagingové CT zatím neprovedeno - výsledek čekáme.

Doporučení:
Případ zadávám k projednání na MDT kolorektálního karcinomu.

Otázka na MDT: Je po neoadjuvantní CHRT a nízké přední resekci rekta (ypT2 ypN0, R0) indikována adjuvantní chemoterapie? Jak dále došetřit vzestup CEA na 9,6 µg/l, je indikováno PET/CT? Kdy je vhodné zrušení protektivní ileostomie?

Doplnit výsledek CT hrudníku, břicha a pánve (žádanka 7.10.2026).
Před zrušením ileostomie doplnit proktografii a endoskopickou kontrolu anastomózy.
Kontrola zde po MDT, s odběrem KO, biochemie, CEA.

Poznámka: Pacientka poučena o povaze onemocnění a dalším postupu, rozumí a souhlasí.

MUDr. Ondřej Habrman, chirurgická ambulance